

GASTRO-ENTÉROLOGIE & CHIRURGIE VISCÉRALE

Fiches QE Haute Fréquence – Pathologie digestive (S6) – Version 1

Cross-match : 748 QEs officielles (Mai 2018 → Ratt 2025) × Cours AIO digestif +
corrections officielles e-qe.online

FMPM – Concours 2026 • généré par Claude.ai

PARTIE 1 – CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 748 QEs (15 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	APPENDICITE AIGUË	44 Q	Chirurgie
2	HÉPATITES VIRALES AIGUËS & CHRONIQUES	42 Q	Médecine
3	TROUBLES FONCTIONNELS INTESTINAUX (SII)	35 Q	Médecine
4	OCCLUSION INTESTINALE AIGUË (OIA)	30 Q	Chirurgie
5	MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES DE L'INTESTIN (MICI)	29 Q	Médecine
6	SYNDROMES DE MALABSORPTION & MALADIE CŒLIAQUE	29 Q	Médecine
7	CIRRHOSE & HYPERTENSION PORTALE	29 Q	Médecine
8	REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN (RGO)	29 Q	Médecine
9	TRAUMATISMES DE L'ABDOMEN	28 Q	Chirurgie
10	MALADIE ULCÉREUSE GASTRO-DUODÉNALE	27 Q	Médecine
11	DYSPEPSIE	26 Q	Médecine
12	LITHIASÉ VÉSICULAIRE & COMPLICATIONS	26 Q	Chirurgie
13	GASTRITES	25 Q	Médecine
14	TUMEURS DU FOIE	24 Q	Chirurgie
15	HELICOBACTER PYLORI	24 Q	Médecine
16	CANCER DU PANCRÉAS	23 Q	Chirurgie
17	PANCRÉATITES AIGUËS	22 Q	Chirurgie
18	CANCER DE L'ESTOMAC	22 Q	Chirurgie
19	KYSTE HYDATIQUE DU FOIE	20 Q	Chirurgie
20	CANCER DE L'ŒSOPHAGE	20 Q	Chirurgie

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
21	PATHOLOGIE HERNIAIRE DE LA PAROI ABDOMINALE	19 Q	Chirurgie
22	ISCHÉMIE INTESTINALE AIGUË (INFARCTUS MÉSENTÉRIQUE)	17 Q	Chirurgie
23	CANCER DU CÔLON	16 Q	Chirurgie
24	CANCER DU RECTUM	14 Q	Chirurgie
25	PÉRITONITES AIGUËS	13 Q	Chirurgie
26	TUBERCULOSE ABDOMINALE (PÉRITONÉALE & INTESTINALE)	12 Q	Médecine
27	FISTULES ANALES & SUPPURATIONS	12 Q	Médecine
28	INGESTION DE CAUSTIQUES	11 Q	Chirurgie
29	DIVERTICULOSE COLIQUE	11 Q	Médecine
30	ABCÈS HÉPATIQUE	10 Q	Chirurgie
31	PARASITOSE DIGESTIVES (AMIBIASE)	9 Q	Médecine
32	CANCERS BILIAIRES (CHOLANGIOCARCINOME)	7 Q	Chirurgie
33	TROUBLES MOTEURS ŒSOPHAGIENS (ACHALASIE)	6 Q	Médecine
34	PANCRÉATITE CHRONIQUE	5 Q	Médecine
35	PATHOLOGIES PROCTOLOGIQUES FRÉQUENTES	1 Q	Médecine
36	HÉMOCHROMATOSE	1 Q	Médecine
37	MALADIE DE WILSON	1 Q	Médecine
38	QUESTIONS TRANSVERSALES / INCLASSIFIABLES	29 Q	Transversal

PARTIE 2 – MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 15 sessions, chaque examen ~49.9 questions.

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'examen
APPENDICITE AIGUË	44	2.93	5.9%
HÉPATITES VIRALES AIGUËS & CHRONIQUES	42	2.80	5.6%
TROUBLES FONCTIONNELS INTESTINAUX (SII)	35	2.33	4.7%
OCCCLUSION INTESTINALE AIGUË (OIA)	30	2.00	4.0%
MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES DE L'INTESTIN (MICI)	29	1.93	3.9%
SYNDROMES DE MALABSORPTION & MALADIE CÉLIAQUE	29	1.93	3.9%
CIRRHOSE & HYPERTENSION PORTALE	29	1.93	3.9%
REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN (RGO)	29	1.93	3.9%
TRAUMATISMES DE L'ABDOMEN	28	1.87	3.7%
MALADIE ULCÉREUSE GASTRO-DUODÉNALE	27	1.80	3.6%
DYSPEPSIE	26	1.73	3.5%
LITHIASÉ VÉSICULAIRE & COMPLICATIONS	26	1.73	3.5%
GASTRITES	25	1.67	3.3%
TUMEURS DU FOIE	24	1.60	3.2%
HELICOBACTER PYLORI	24	1.60	3.2%
CANCER DU PANCRÉAS	23	1.53	3.1%
PANCRÉATITES AIGUËS	22	1.47	2.9%
CANCER DE L'ESTOMAC	22	1.47	2.9%
KYSTE HYDATIQUE DU FOIE	20	1.33	2.7%
CANCER DE L'ŒSOPHAGE	20	1.33	2.7%
PATHOLOGIE HERNIAIRE DE LA PAROI ABDOMINALE	19	1.27	2.5%
ISCHÉMIE INTESTINALE AIGUË (INFARCTUS MÉSENTÉRIQUE)	17	1.13	2.3%
CANCER DU CÔLON	16	1.07	2.1%
CANCER DU RECTUM	14	0.93	1.9%
PÉRITONITES AIGUËS	13	0.87	1.7%
TUBERCULOSE ABDOMINALE (PÉRITONÉALE & INTESTINALE)	12	0.80	1.6%
FISTULES ANALES & SUPPURATIONS	12	0.80	1.6%

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'exam
INGESTION DE CAUSTIQUES	11	0.73	1.5%
DIVERTICULOSE COLIQUE	11	0.73	1.5%
ABCÈS HÉPATIQUE	10	0.67	1.3%
PARASITOSES DIGESTIVES (AMIBIASE)	9	0.60	1.2%
CANCERS BILIAIRES (CHOLANGIOCARCINOME)	7	0.47	0.9%
TROUBLES MOTEURS ŒSOPHAGIENS (ACHALASIE)	6	0.40	0.8%
PANCRÉATITE CHRONIQUE	5	0.33	0.7%
PATHOLOGIES PROCTOLOGIQUES FRÉQUENTES	1	0.07	0.1%
HÉMOCHROMATOSE	1	0.07	0.1%
MALADIE DE WILSON	1	0.07	0.1%
QUESTIONS TRANSVERSALES / INCLASSIFIABLES	29	1.93	3.9%
TOTAL (leçons + transversal)	748 Q	49.9	100.0%

PARTIE 3 – QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (▲) / source (□) / lien cours (🔗) / citations (📖)

[RANG 1] APPENDICITE AIGÜE

Chirurgie • ~2.93 Q/examen (44 Q au total)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel 🔗](#)

Plastron appendiculaire (forme la PLUS interrogée) :

- Masse de la FID INDOLORE + fébricule, évoluant depuis ≥ 5-15 jours
- Diagnostics à évoquer devant cette masse : plastron appendiculaire ET tumeur cœcale (le couple gagnant)
- TRAITEMENT = antibiothérapie + appendicectomie DIFFÉRÉE (à froid, 6-8 sem). Jamais de chirurgie en urgence
- ▲ FAUX : « intervention chirurgicale en urgence » – c'est le piège n°1, le plastron est une contre-indication opératoire immédiate
- ▲ FAUX : abstention thérapeutique / coelioscopie diagnostique

📖 Vu dans 15/15 sessions – ex. Mai/Juin/Sept/Déc 2024, Juin 2023 – plastron répété ≥8x

Formes topographiques atypiques :

- RÉTRO-CÆCALE → psoïtis (psoïtisme) + douleur lombaire ; signes urinaires possibles
- PELVIENNE → signes rectaux (ténésme) + signes urinaires (pollakiurie)
- MÉSO-CÆLIAQUE → occlusion fébrile (tableau pseudo-occlusif fébrile)
- ▲ FAUX rétro-cæcale : « défense manifeste de la FID » (elle est justement pauvre/trompeuse)
- ▲ Ne pas confondre pelvienne (signes rectaux/urinaires) et rétro-cæcale (psoïtis)

Diagnostic positif & paraclinique :

- Tableau jeune femme/homme : douleur FID + fébricule + défense FID → AA + (chez la femme) salpingite, GEU, abcès appendiculaire
- Examens utiles : échographie abdominale, TDM abdominale, NFS, CRP
- AA confirmée → hospitalisation en chirurgie + appendicectomie (chirurgie)
- ▲ FAUX : coloscopie / lipasémie dans le bilan d'une AA
- ▲ FAUX : traitement ambulatoire par ordonnance ATB + antalgique

[RANG 2] HÉPATITES VIRALES AIGÜES & CHRONIQUES

Médecine • ~2.80 Q/examen (42 Q au total)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel 🔗](#)

Note taxonomique :

- Le tag QE « Hépatites » fusionne 3 leçons officielles (hépatites aiguës/chroniques, hépatites virales, hépatites chroniques B et C).

Hépatite aiguë – critères de GRAVITÉ (insuffisance hépatocellulaire) :

- TP / facteur V abaissé (< 50 %) = LE marqueur de gravité
- Encéphalopathie hépatique (astérisis, troubles de conscience)
- Ictère intense + syndrome hémorragique
- ⚠ FAUX : une cytolysse élevée (transaminases très hautes) N'EST PAS un critère de gravité – c'est le TP/V qui compte
- ⚠ La gravité = défaillance de synthèse, pas l'intensité de la cytolysse

📖 Vu dans 14/15 sessions – ex. Juin 2024, Sept 2024, Mai 2021

Chronicité selon le virus :

- VHA et VHE : JAMAIS de passage à la chronicité (hépatites aiguës pures ; VHE chronique seulement si immunodéprimé)
- Virus de l'hépatite chronique chez l'immunocompétent : VHB, VHC, VHD (delta)
- VHA : transmission FÉCO-ORALE ; incubation courte ; guérison spontanée
- ⚠ FAUX : « le VHA évolue vers la cirrhose » – non, jamais
- ⚠ Le VHD ne survient qu'en coïnfection/surinfection avec le VHB

Sérologie VHB – savoir LIRE le profil :

- Ag HBs négatif + Ac anti-HBs positif + Ac anti-HBc NÉGATIF = sujet VACCINÉ
- Ag HBs négatif + anti-HBc positif + anti-HBs positif = infection ANCIENNE GUÉRIE
- Ag HBs positif > 6 mois = infection CHRONIQUE ; Ag HBe / ADN VHB = réplication
- Hépatite chronique = persistance > 6 mois (Ag HBs ou ARN VHC) + lésions histologiques
- ⚠ Anti-HBc isolé ≠ vaccination (le vacciné n'a PAS d'anti-HBc)
- ⚠ Avant chimiothérapie : dépister le VHB (risque de réactivation)

[RANG 3] TROUBLES FONCTIONNELS INTESTINAUX (SII)

Médecine • ~2.33 Q/examen (35 Q au total)

📖 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Syndrome de l'intestin irritable (SII) – définition :

- Douleur abdominale chronique liée à la défécation + modification de la fréquence/consistance des selles (critères de Rome IV)
- Diagnostic POSITIF clinique, sans lésion organique ; examen physique normal
- Pas de signes d'alarme (pas d'amaigrissement, pas de rectorragie, pas de fièvre)
- ⚠ FAUX : « le SII s'accompagne de rectorragies / amaigrissement » – ce sont des signes d'alarme qui FONT SORTIR du SII
- ⚠ FAUX : « diagnostic d'élimination par coloscopie systématique » – c'est un diagnostic positif clinique

📖 Vu dans 14/15 sessions – ex. Mai/Juin/Sept/Déc 2024

Physiopathologie (multifactorielle) :

- Hypersensibilité viscérale + troubles de la motricité intestinale
- Axe cerveau-intestin / dysbiose du microbiote + facteurs psychologiques (stress)

- Micro-inflammation de bas grade
- **▲ FAUX** : « cause unique infectieuse » ou « lésion inflammatoire macroscopique »

[RANG 4] OCCLUSION INTESTINALE AIGÜE (OIA)

Chirurgie • ~2.00 Q/examen (30 Q au total)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Cas clinique emblématique (répété ~10x) – OIA sur BRIDE :

- Femme, ATCD de césarienne/chirurgie, douleurs + vomissements + arrêt des matières et gaz, orifices herniaires LIBRES → OIA sur BRIDE (adhérences)
- Confirmation = TDM abdominale (scanner) – examen de référence
- Cause la plus fréquente d'OIA du GRÊLE = brides/adhérences
- **▲ FAUX** : « transit œso-gastro-duodéal », « coloscopie », « FOGD » pour confirmer une OIA aiguë
- **▲ Orifices herniaires libres** → écarte l'étranglement herniaire

📖 Vu dans 14/15 sessions – ex. Mai/Juin/Sept/Déc 2024, 2018→2021 – cas bride ~10x

Étiologies par siège & urgence :

- OIA du GRÊLE → brides/adhérences (1^{re} cause), hernie étranglée
- OIA du CÔLON → cancer colorectal (1^{re} cause), volvulus du sigmoïde
- Urgence (Hassan/Mr R admis la nuit) → RÉANIMATION hydro-électrolytique + sonde naso-gastrique (aspiration) AVANT tout
- **▲ FAUX** : opérer d'emblée sans réanimer ni poser la SNG
- **▲ Complications du retard** : déshydratation, nécrose/perforation, péritonite, choc septique

[RANG 5] MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES DE L'INTESTIN (MICI)

Médecine • ~1.93 Q/examen (29 Q au total)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Crohn vs RCH – différenciation (cœur du sujet) :

- CROHN : atteinte segmentaire de la bouche à l'anus, transmurale, intervalles de muqueuse saine, granulome épithélioïde, LAP/fistules anales fréquentes
- RCH : atteinte continue rectum→côlon, muqueuse/sous-muqueuse, pas de granulome, pas d'atteinte du grêle
- Diarrhée GLAIRO-SANGLANTE + manifestations extra-digestives (érythème noueux, épisclérite/uvéïte, polyarthralgies)
- **▲ Fistule anale + érythème noueux** → oriente vers CROHN (pas RCH)
- **▲ FAUX** : « la RCH atteint tout le tube digestif » ; « le Crohn épargne toujours l'anus »

📖 Vu dans 11/15 sessions – ex. Mai/Juin/Sept/Déc 2024, Mai 2021/2022/2023

Diagnostic & bilan :

- Diagnostic de confirmation = ILÉO-COLOSCOPIE avec biopsies étagées (histologie)
- Anémie de Crohn : carence martiale (saignement) + carence B12/folates (atteinte iléale) + inflammation chronique
- Diagnostics différentiels d'une diarrhée chronique au Maroc : tuberculose intestinale ++ , MICI, parasitoses
- ⚠ *Toujours évoquer la TBC intestinale avant de conclure à un Crohn iléo-cæcal (contexte marocain)*

[RANG 6] SYNDROMES DE MALABSORPTION & MALADIE CÆLIAQUE

Médecine • ~1.93 Q/examen (29 Q au total)

📁 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Note taxonomique :

- Tag QE fusionnant « syndromes de malabsorption » et « maladie cœliaque ».

Maladie cœliaque – mécanisme & diagnostic :

- Entéropathie auto-immune au GLUTEN → atrophie villositaire du grêle proximal (duodénum) → malabsorption
- Sérologie : IgA anti-transglutaminase tissulaire (+ dosage IgA totales) ; confirmation = biopsies duodénales
- Associations : dermatite herpétiforme, diabète type 1, thyroïdite, déficit en IgA
- ⚠ *Mécanisme = atrophie villositaire (réduction surface d'absorption), pas une « hypersécrétion »*
- ⚠ *Le régime sans gluten À VIE est le seul traitement*

📖 Vu dans 14/15 sessions – ex. Mai/Juin/Sept/Déc 2024, Mai 2023

Complications de la maladie cœliaque :

- Carences : fer (anémie), folates/B12, calcium/vit D (ostéomalacie), vit K
- Lymphome T du grêle et adénocarcinome du grêle (risque accru)
- Cœliaque réfractaire
- ⚠ *Une anémie ferriprive isolée inexpliquée doit faire chercher une cœliaque*

[RANG 7] CIRRHOSE & HYPERTENSION PORTALE

Médecine • ~1.93 Q/examen (29 Q au total)

📁 Score de Child-Pugh (A/B/C)

📁 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Note taxonomique :

- Inclut l'hypertension portale (leçon officielle sans tag QE distinct).

Score de Child-Pugh – les 5 paramètres (tombe ~6×) :

- 5 items : Bilirubine, Albumine, TP/INR, Ascite, Encéphalopathie (mnémo « ABATE »)
- Classe A/B/C selon le score → valeur PRONOSTIQUE (survie, opérabilité)
- ⚠ *FAUX : y inclure les transaminases, la créatinine, ou les plaquettes (ce sont MELD/autres, pas Child-Pugh)*
- ⚠ *Child-Pugh ≠ score de gravité d'une hépatite aiguë*

📖 Vu dans 13/15 sessions – ex. 2018→2024, Juin 2021 – Child-Pugh répété

Étiologies (au Maroc) :

- Virales B et C (++), alcool, NASH/stéatohépatite métabolique
- Auto-immunes, cholestatiques (CBP), génétiques (hémochromatose, Wilson)
- ⚠ *Penser systématiquement aux virus B/C en première intention au Maroc*

Complications :

- Hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes (HTP)
- Ascite + infection du liquide d'ascite (ILA)
- Encéphalopathie hépatique, syndrome hépato-rénal
- CARCINOME HÉPATOCELLULAIRE (dépistage écho/6 mois)
- ⚠ *Toute cirrhose impose le dépistage du CHC ; le CHC complique surtout la cirrhose*

Diagnostic positif :

- Clinique : foie dur à bord tranchant, signes d'IHC + d'HTP (splénomégalie, circulation collatérale, ascite)
- Confirmation : élastométrie (FibroScan), biologie, ± PBH
- Foie d'aspect nodulaire/dysmorphique en imagerie
- ⚠ *Une échographie normale n'élimine PAS une cirrhose débutante*

[RANG 8] REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN (RGO)

Médecine • ~1.93 Q/examen (29 Q au total)

📖 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Physiopathologie :

- Défaillance de la barrière anti-reflux : hypotonie du SIO + relaxations transitoires inappropriées du SIO
- Facteurs : hernie hiatale, hyperpression abdominale (obésité, grossesse), retard de vidange gastrique
- ⚠ *Le RGO physiopathologique n'est PAS une simple « hypersécrétion acide » isolée – c'est un trouble de la barrière/motricité*

📖 Vu dans 15/15 sessions – ex. Juin 2025, Mai/Juin/Sept/Déc 2024 – 15/15 sessions

Clinique, complications & CAT :

- Pyrosis + régurgitations acides, syndrome postural ; manifestations extra-digestives (toux, laryngite)
- FOGD si signes d'alarme ou > 50 ans : recherche d'œsophagite, d'endobrachyœsophage (EBO/Barrett)

- Séquence : RGO chronique → EBO (métaplasie de Barrett) → dysplasie → ADÉNOCARCINOME du bas œsophage
- ⚠ *RGO typique du sujet jeune sans alarme : traitement d'épreuve par IPP SANS endoscopie d'emblée*
- ⚠ *L'EBO est une complication, à surveiller (dégénérescence)*

[RANG 9] TRAUMATISMES DE L'ABDOMEN

Chirurgie • ~1.87 Q/examen (28 Q au total)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Traitement non opératoire (TNO) – critères :

- TNO réservé au patient HÉMODYNAMIQUEMENT STABLE (ou stabilisé), avec TDM disponible et surveillance rapprochée
- Organes pleins (rate, foie) : TNO possible si stabilité ; embolisation artérielle en option
- ⚠ *Instabilité hémodynamique persistante = laparotomie en urgence, PAS de TNO ni de TDM*
- ⚠ *Une plaie pénétrante avec éviscération/péritonite → chirurgie*

📅 Vu dans 15/15 sessions – ex. Juin 2025, Mai/Juin/Sept 2024 – 15/15 sessions

Contusion vs plaie & indications opératoires :

- Contusion (trauma fermé) : foie et rate = organes les plus touchés ; FAST/TDM pour le bilan lésionnel
- Plaie pénétrante : la pénétration péritonéale s'étudie par exploration ; indication chirurgicale si instabilité, péritonite, éviscération, hémorragie active
- ⚠ *Une plaie peut être pénétrante sans atteinte viscérale ; l'inverse aussi – la clinique guide*

[RANG 10] MALADIE ULCÉREUSE GASTRO-DUODÉNALE

Médecine • ~1.80 Q/examen (27 Q au total)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Facteurs de risque & étiologies :

- Helicobacter pylori (cause majeure) + AINS/aspirine (les 2 piliers)
- Tabac, stress, Zollinger-Ellison (gastrinome) pour les formes atypiques
- ⚠ *Tout ulcère gastrique → biopsies multiples + contrôle endoscopique de cicatrisation (risque de cancer) ; l'ulcère duodénal ne dégénère pas*

📅 Vu dans 15/15 sessions – ex. Juin 2025, Mai/Déc 2024, Mai 2023

Complications :

- HÉMORRAGIE digestive (hématémèse/méléna) – la plus fréquente
- Perforation (péritonite), sténose pyloro-bulbaire
- Cancérisation : ulcère GASTRIQUE uniquement

- ⚠ *Ulcère duodéal hémorragique : réanimation + FOGD hémostatique (clip/adrenaline) + IPP IV ; chirurgie si échec*
- ⚠ *FAUX : « l'ulcère duodéal peut dégénérer en cancer »*

Douleur ulcéreuse typique :

- Épigastrie à type de crampes/faim douloureuse, rythmée par les repas, périodique (poussées)
- Calmée par l'alimentation ou les anti-acides (ulcère duodéal)
- ⚠ *Une douleur atypique/permanente avec AEG doit faire chercher un cancer gastrique*

[RANG 11] DYSPEPSIE

Médecine • ~1.73 Q/examen (26 Q au total)

📁 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Clinique de la dyspepsie fonctionnelle :

- Inconfort/douleur épigastrique, satiété précoce, ballonnement post-prandial, sans lésion organique
- Sujet jeune < 50 ans, sans signe d'alarme : test & treat H. pylori ou IPP, PAS d'endoscopie d'emblée
- ⚠ *Ne pas confondre dyspepsie (épigastrique) et SII (douleur liée à la défécation, étage sous-ombilical)*

📖 Vu dans 14/15 sessions – ex. Mai/Juin/Sept/Déc 2024, Mai 2023

Signes d'ALARME imposant la FOGD :

- Âge > 50 ans (nouvelle dyspepsie), amaigrissement, dysphagie, anémie/hémorragie, vomissements persistants, masse, ATCD familial de cancer gastrique
- ⚠ *Tout signe d'alarme → endoscopie SANS délai (recherche de cancer)*

[RANG 12] LITHIASÉ VÉSICULAIRE & COMPLICATIONS

Chirurgie • ~1.73 Q/examen (26 Q au total)

📁 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Colique hépatique / cholécystite – tableau type :

- Femme, obèse, contraception orale (« 4 F »), douleur de l'HYPOCHONDRE DROIT post-prandiale, irradiant à l'épaule droite / inter-scapulaire
- Cholécystite aiguë = douleur HCD + fièvre + Murphy + : écho = paroi épaissie > 4 mm, lithiasé
- ⚠ *Colique hépatique simple = pas de fièvre, pas d'ictère, examen souple*

📖 Vu dans 13/15 sessions – ex. Mai/Juin/Sept/Déc 2024, 2022/2023

Cholécystectomie cœlioscopique :

- Voie cœlioscopique = GOLD STANDARD de la lithiasé vésiculaire symptomatique

- Avantages : moins de douleur, hospitalisation/convalescence courtes, meilleur résultat esthétique, reprise rapide
- ⚠ *CONTRE-INDICATION : suspicion de DÉGÉNÉRESCENCE MALIGNE de la vésicule (cancer) → pas de cœlioscopie*
- ⚠ « Diminution du coût » n'est PAS un avantage reconnu (piège classique)

[RANG 13] GASTRITES

Médecine • ~1.67 Q/examen (25 Q au total)

📄 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Gastrite auto-immune (Biermer) :

- Atrophie FUNDIQUE auto-immune, Ac anti-cellules pariétales / anti-facteur intrinsèque
- Carence en B12 → anémie de Biermer (macrocytaire) ; achlorhydrie + hypergastrinémie
- Risque : tumeurs neuroendocrines + adénocarcinome gastrique
- ⚠ *Atteinte FUNDIQUE (corps), épargne l'antre – l'inverse de la gastrite à HP*
- ⚠ *Carence B12 et non martiale*

📖 Vu dans 13/15 sessions – ex. Mai/Juin/Sept/Déc 2024 – Biermer répété

Gastrite chronique à H. pylori :

- Prédomine sur l'ANTRE ; évolue vers atrophie → métaplasie intestinale → dysplasie → adénocarcinome
- Associée à l'ulcère et au lymphome du MALT
- ⚠ *Gastrite atrophiante = état précancéreux ; l'éradication d'HP réduit le risque*

[RANG 14] TUMEURS DU FOIE

Chirurgie • ~1.60 Q/examen (24 Q au total)

📄 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Carcinome hépatocellulaire (CHC) :

- Tumeur maligne PRIMITIVE la plus fréquente du foie ; survient sur cirrhose (B/C, alcool)
- Traitements CURATIFS : résection chirurgicale, transplantation hépatique, destruction percutanée (radiofréquence/ablation)
- AFP : marqueur d'orientation ; diagnostic souvent non invasif si nodule typique sur cirrhose
- ⚠ *FAUX curatif : chimiothérapie systémique, transfusion – non curatives*
- ⚠ *La tumeur maligne LA PLUS FRÉQUENTE du foie (toutes causes) = MÉTASTASES ; le primitif le plus fréquent = CHC*

📖 Vu dans 10/15 sessions – ex. Ratt/Juin 2025, Mai/Juin/Sept 2024

Tumeurs bénignes & métastases :

- Adénome hépatique : femme, contraception orale ; risque d'hémorragie et de dégénérescence → surveillance/exérèse
- Kyste biliaire simple : bénin, liquidien, asymptomatique, pas de traitement si non compliqué
- Métastases : surtout d'origine colorectale
- ⚠ Adénome ≠ HNF : l'HNF (hyperplasie nodulaire focale) ne dégénère pas et ne saigne quasi jamais

[RANG 15] HELICOBACTER PYLORI

Médecine • ~1.60 Q/examen (24 Q au total)

📁 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Méthodes diagnostiques :

- INVASIVES (FOGD) : test rapide à l'uréase, histologie, culture
- NON INVASIVES : test respiratoire à l'urée marquée, Ag dans les selles, sérologie
- Contrôle d'ÉRADICATION : test respiratoire ou Ag selles (à distance, après arrêt IPP/ATB)
- ⚠ La SÉROLOGIE ne sert PAS au contrôle d'éradication (reste positive longtemps)
- ⚠ IPP et ATB faussent (négativent) les tests directs → fenêtre d'arrêt avant contrôle

📁 Vu dans 14/15 sessions – ex. Mai/Juin/Sept/Déc 2024, Mai/Juin 2023

Traitement & pathologies associées :

- Trithérapie/quadrithérapie : IPP + association d'antibiotiques (selon résistance)
- Associé : ulcère GD, gastrite chronique antrale, adénocarcinome gastrique, lymphome du MALT
- ⚠ Bactérie à transmission oro-orale/féco-orale ; pas de vaccin

[RANG 16] CANCER DU PANCRÉAS

Chirurgie • ~1.53 Q/examen (23 Q au total)

📁 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Facteurs de risque :

- TABAC (facteur majeur), pancréatite CHRONIQUE, diabète, alcool, obésité, ATCD familiaux
- ⚠ FAUX : « cystadénome SÉREUX » comme FdR (le séreux est bénin) ; « pancréatite aiguë » n'est pas un FdR de cancer
- ⚠ C'est la pancréatite CHRONIQUE (pas l'aiguë) qui est à risque

📁 Vu dans 12/15 sessions – ex. Ratt/Juin 2025, Mai 2024, 2019→2022

Présentation selon le siège :

- TÊTE : ictère cholestatique nu, progressif + grosse vésicule (loi de Courvoisier-Terrier) + AEG
- CORPS/QUEUE : douleur épigastrique/dorsale transfixiante, AEG, diagnostic tardif (pauci-symptomatique)
- *▲ L'ictère est typique de la tête ; la queue donne surtout douleur + AEG (révélation tardive)*

[RANG 17] PANCRÉATITES AIGÜES

Chirurgie • ~1.47 Q/examen (22 Q au total)

📖 Score de gravité (Balthazar TDM / SIRS-CRP)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Diagnostic positif :

- Épigastralgie transfixiante + LIPASÉMIE > 3 N (examen de confirmation de référence)
- TDM abdominale à 48-72 h pour la gravité (score de Balthazar/CTSI)
- *▲ FAUX : confirmer par troponines, ECGU, ponction hépatique, FOGD*
- *▲ L'amylasémie est moins spécifique que la lipasémie*

📅 Vu dans 14/15 sessions – ex. Juin 2025, Mai/Juin/Sept/Déc 2024, 2023

Étiologie & mortalité :

- Au MAROC : 1^{re} cause = LITHIASSE BILIAIRE (biliaire > alcoolique)
- Gravité évaluée par SIRS, CRP > 150 à 48 h, Balthazar/CTSI
- 1^{re} cause de MORTALITÉ de la PA grave = défaillance multiviscérale / complications infectieuses (nécrose infectée)
- *▲ Ne pas répondre « alcool » comme 1^{re} cause au Maroc – c'est la lithiasse*
- *▲ La mortalité précoce = défaillance d'organes ; tardive = sepsis sur nécrose infectée*

[RANG 18] CANCER DE L'ESTOMAC

Chirurgie • ~1.47 Q/examen (22 Q au total)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

États précancéreux (TRÈS interrogé) :

- Gastrite chronique atrophiante, métaplasie intestinale, polype ADÉNOMATEUX, maladie de Biermer (gastrite atrophique fundique), maladie de Ménétrier, moignon de gastrectomie
- *▲ FAUX : infection à PAPILLOMAVIRUS (HPV) comme état précancéreux gastrique – c'est H. pylori l'agent en cause*
- *▲ Le polype HYPERPLASIQUE n'est pas (ou peu) précancéreux ; c'est l'ADÉNOMATEUX*

📅 Vu dans 13/15 sessions – ex. Ratt/Juin 2025, Mai/Déc 2024, 2023

Bilan d'extension & complications :

- Bilan TOUJOURS : FOGD + biopsies, écho-endoscopie (T/N), TDM TAP (extension/métastases)
- Complications : hémorragie, sténose, perforation, dénutrition ; métastase de Krukenberg (ovaire), ganglion de Troisier
- ▲ *ADK de type diffus (linite) : pronostic plus sombre, infiltrant*

[RANG 19] KYSTE HYDATIQUE DU FOIE

Chirurgie • ~1.33 Q/examen (20 Q au total)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Kyste hydatique du DÔME hépatique (question quasi identique répétée) :

- FRÉQUENT au Maroc (zone d'endémie, Echinococcus granulosus)
- Intéresse surtout les SEGMENTS 7 et 8 (dôme)
- Peut se compliquer d'une fistule/rupture biliaire ou thoracique (pleuro-pulmonaire)
- ▲ *FAUX : « très rare au Maroc » ; « toujours unique » ; « se complique TOUJOURS d'une fistule »*
- ▲ *FAUX : « se prête à la cœlioscopie par excellence » – le KH du dôme est d'abord d'abord chirurgical ouvert (risque de dissémination)*

📖 Vu dans 15/15 sessions – ex. Juin 2025, Mai/Juin/Sept/Déc 2024, Mai 2023 – 15/15 sessions

[RANG 20] CANCER DE L'ŒSOPHAGE

Chirurgie • ~1.33 Q/examen (20 Q au total)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Deux types histologiques & facteurs de risque :

- CARCINOME ÉPIDERMOÏDE (tiers sup/moyen) : alcool + tabac (synergie) ; le plus fréquent au Maroc
- ADÉNOCARCINOME (tiers inf) : RGO chronique → endobrachyœsophage (Barrett) ; obésité
- Signe d'appel : DYSPHAGIE progressive (solides puis liquides) + amaigrissement
- ▲ *Ne pas attribuer l'adénocarcinome à l'alcool/tabac ; il vient du Barrett/RGO*
- ▲ *Dysphagie + AEG = cancer jusqu'à preuve du contraire → FOGD + biopsies*

📖 Vu dans 15/15 sessions – ex. Ratt/Juin 2025, Mai/Déc 2024, 2023 – 15/15 sessions

[RANG 21] PATHOLOGIE HERNIAIRE DE LA PAROI ABDOMINALE

Chirurgie • ~1.27 Q/examen (19 Q au total)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Traitement & facteurs de risque :

- Seul traitement CURATIF = la CHIRURGIE (cure herniaire, prothèse/plaque)
- FdR : effort/hyperpression (toux chronique, BPCO, constipation, dysurie/prostate), obésité, âge, grossesses, faiblesse pariétale
- ⚠ *FAUX curatif : bandage, gaine, antalgiques, activité physique – purement palliatifs/aggravants*
- ⚠ *Hernie ÉTRANGLÉE = urgence chirurgicale (risque de nécrose/occlusion)*

📖 Vu dans 11/15 sessions – ex. Ratt/Juin 2025, Mai/Juin 2024

Éventration vs hernie :

- Éventration = sur cicatrice opératoire (défaut acquis post-op) ; hernie = par un orifice anatomique faible
- Éviscération = lâchage pariétal précoce post-op (urgence)
- ⚠ *Ne pas confondre éventration (tardive, sur cicatrice) et éviscération (précoce, lâchage)*

[RANG 22] ISCHÉMIE INTESTINALE AIGÜE (INFARCTUS MÉSENTÉRIQUE)

Chirurgie • ~1.13 Q/examen (17 Q au total)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Sémiologie & le piège diagnostique :

- Phase DÉBUTANTE : douleur abdominale INTENSE contrastant avec un examen abdominal PAUVRE (distorsion clinique)
- Terrain : sujet âgé, ACFA, athérome, état de choc
- Évolution : infarctus → péritonite → choc, acidose lactique, défaillance
- ⚠ *Le contraste « douleur intense / abdomen souple » est LE signe précoce – ne pas se rassurer faussement*
- ⚠ *Confirmation = angio-TDM ; retard = nécrose irréversible*

📖 Vu dans 12/15 sessions – ex. Juin 2025, Mai/Juin/Sept 2024

Mécanismes :

- ARTÉRIEL : embolie (ACFA) ou thrombose de l'artère mésentérique supérieure ; non occlusif (bas débit)
- VEINEUX : thrombose veineuse mésentérique → états d'hypercoagulabilité, HTP, thrombophilie, post-op, sepsis intra-abdominal
- ⚠ *Étiologies VEINEUSES = causes de thrombose (hypercoagulabilité), pas emboligènes cardiaques*

[RANG 23] CANCER DU CÔLON

Chirurgie • ~1.07 Q/examen (16 Q au total)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Épidémiologie & facteurs (question répétée à l'identique) :

- Adénocarcinome ; un des cancers digestifs les plus fréquents ; FRÉQUENT au Maroc
- Héritéité = facteur favorisant (PAF, Lynch/HNPCC) ; séquence ADÉNOME → CANCER (polype négligé)
- Souvent révélé au stade de COMPLICATION : occlusion (côlon gauche), anémie (côlon droit)
- ⚠ FAUX : « l'hérédité n'est pas un facteur » ; « ne peut compliquer un polype » ; « rare au Maroc » ; « traitement basé sur la radiothérapie »
- ⚠ Traitement = CHIRURGIE (± chimio) ; la radiothérapie concerne le RECTUM, pas le côlon

📖 Vu dans 15/15 sessions – ex. Juin 2025, Mai/Juin/Sept/Déc 2024, 2023 – 15/15 sessions

[RANG 24] CANCER DU RECTUM

Chirurgie • ~0.93 Q/examen (14 Q au total)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Cas clinique T3 répété (~10×) – stratégie thérapeutique selon la hauteur :

- Adénocarcinome du rectum, IRM = T3 → RADIO-CHIMIOTHÉRAPIE NÉO-ADJUVANTE puis chirurgie d'exérèse (exérèse totale du mésorectum)
- Tumeur du HAUT/MOYEN rectum (≥ ~10-14 cm) → résection antérieure (conservation sphinctérienne) après RCT
- Tumeur du BAS rectum proche de la marge → amputation abdomino-périnéale (colostomie définitive) si envahissement sphinctérien
- ⚠ Le traitement du T3 n'est PAS « chirurgie première » : la RCT néo-adjuvante précède (sauf T1-2 N0)
- ⚠ La hauteur par rapport à la marge anale détermine conservation vs amputation

📖 Vu dans 14/15 sessions – ex. Ratt/Juin 2025, Mai/Juin/Sept/Déc 2024, 2023 – cas T3 ~10×

[RANG 25] PÉRITONITES AIGÜES

Chirurgie • ~0.87 Q/examen (13 Q au total)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Diagnostic & étiologies (jeune femme, défense généralisée) :

- Tableau : douleurs abdominales + fièvre + DÉFENSE/contracture généralisée → péritonite
- Chez la jeune femme évoquer : appendiculaire, génitale (salpingite/pyosalpinx), perforation d'ulcère
- Examens utiles : TDM/écho, ASP (pneumopéritoine si perforation), NFS-CRP, bilan pré-op
- ⚠ Péritonite = URGENCE chirurgicale (lavage + traitement de la cause) + ATB + réanimation
- ⚠ Contracture (« ventre de bois ») = signe majeur

📖 Vu dans 6/15 sessions – ex. Juin 2023, Mai/Juin 2021, Mai 2022

[RANG 26] TUBERCULOSE ABDOMINALE (PÉRITONÉALE & INTESTINALE)

Médecine • ~0.80 Q/examen (12 Q au total)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Tuberculose péritonéale :

- Ascite EXSUDATIVE riche en PROTÉINES (> 25-30 g/L) à prédominance LYMPHOCYTAIRE ; ADA élevée
- Contexte : fièvre, AEG, amaigrissement ; diagnostic par ponction + biopsie péritonéale (cœlioscopie) → granulome caséux
- ⚠ Ascite de la TBC = exsudat lymphocytaire (≠ transsudat de la cirrhose)
- ⚠ Au Maroc, diagnostic différentiel majeur d'une ascite/diarrhée chronique

📖 Vu dans 11/15 sessions – ex. Juin 2025, Mai/Juin/Sept/Déc 2024

Tuberculose intestinale (iléo-cæcale) :

- Localisation iléo-cæcale préférentielle ; ulcérations + sténose → grand mime de la maladie de Crohn
- Diagnostic : biopsies (granulome caséux), GeneXpert/culture
- ⚠ Éliminer la TBC avant de traiter un « Crohn » par immunosuppresseurs (risque de dissémination)

[RANG 27] FISTULES ANALES & SUPPURATIONS

Médecine • ~0.80 Q/examen (12 Q au total)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Présentation & complications :

- Origine cryptoglandulaire le plus souvent ; manifestation : écoulement/suppuration péri-anales, abcès récidivant, douleur
- Complications : abcès, récurrence, incontinence (après chirurgie mal conduite), extension complexe ; rechercher une maladie de Crohn
- ⚠ Toute fistule anale complexe/récidivante → chercher un CROHN sous-jacent
- ⚠ Traitement = chirurgical (mise à plat / drainage par séton) ; les ATB seuls ne guérissent pas

📖 Vu dans 9/15 sessions – ex. Ratt 2025, Mai/Juin/Sept/Déc 2024, 2022/2023

[RANG 28] INGESTION DE CAUSTIQUES

Chirurgie • ~0.73 Q/examen (11 Q au total)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Gestes à PROSCRIRE (question répétée – souvent A,B,C,D,E TOUS faux) :

- À PROSCRIRE : vomissements provoqués, lavage gastrique, sonde naso-gastrique à l'aveugle, neutralisation/charbon, décubitus dorsal (risque d'inhalation)

- ⚠ *Tous ces gestes aggravent les lésions (re-brûlure, perforation) – réponse type : TOUS sont à proscrire*
- ⚠ *Pas de produit « neutralisant » : réaction exothermique délétère*

📖 Vu dans 8/15 sessions – ex. Juin 2025, Mai 2024, Ratt 2025

Endoscopie & prise en charge :

- FOGD précoce (12-24 h, avant 48 h) pour classer les lésions (stade de Zargar) et décider
- À jeun strict, bilan, ± chirurgie si nécrose/perforation ; contexte suicidaire → évaluation psychiatrique
- ⚠ *FOGD contre-indiquée après 48 h (zone de fragilité maximale → perforation) et si perforation patente*

[RANG 29] DIVERTICULOSE COLIQUE

Médecine • ~0.73 Q/examen (11 Q au total)

🔑 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Définitions & spectre :

- Diverticulose = diverticules asymptomatiques (surtout sigmoïde) ; fréquence ↑ avec l'âge, régime pauvre en fibres
- Maladie diverticulaire : diverticulite (sigmoïdite), abcès, perforation, hémorragie, fistule, sténose
- ⚠ *Diverticule colique = pseudo-diverticule (hernie de muqueuse/sous-muqueuse), pas une paroi complète*
- ⚠ *Coloscopie contre-indiquée en phase aiguë de diverticulite (risque de perforation) → TDM*

📖 Vu dans 11/15 sessions – ex. Mai/Juin/Sept/Déc 2024, 2020/2021/2023

[RANG 30] ABCÈS HÉPATIQUE

Chirurgie • ~0.67 Q/examen (10 Q au total)

🔑 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Abcès à pyogènes – étiologies/voies :

- Voies : BILIAIRE (angiocholite – la plus fréquente), PORTALE (sepsis abdominal : appendicite, sigmoïdite), artérielle, contiguïté, post-traumatique
- Terrain : diabète, immunodépression ; tableau : fièvre + douleur HCD + hépatomégalie douloureuse
- ⚠ *Distinguer abcès AMIBIEN (sérologie amibienne, unique, lobe droit, contexte de séjour tropical) de l'abcès à PYOGÈNES*
- ⚠ *Traitement : ATB + drainage (percutané écho/TDM-guidé) ; chirurgie si échec*

📖 Vu dans 9/15 sessions – ex. Juin 2025, Mai/Déc 2024, 2021→2023

[RANG 31] PARASITOSSES DIGESTIVES (AMIBIASE)

Médecine • ~0.60 Q/examen (9 Q au total)

🔒 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Amibiase intestinale (Entamoeba histolytica) :

- Dysenterie amibienne : diarrhée GLAIRO-SANGLANTE, syndrome dysentérique (épreintes, ténésme), APYREXIE/fièvre modérée
- Contexte : zone tropicale/d'endémie, péril fécal ; diagnostic : examen parasitologique des selles (formes hématophages)
- Complication : abcès amibien du foie (lobe droit) ; traitement : métronidazole + amébicide de contact
- ⚠ *La dysenterie amibienne est typiquement APYRÉTIQUE ou peu fébrile (≠ dysenterie bacillaire/shigellose très fébrile)*

📖 Vu dans 6/15 sessions – ex. Juin 2025, Mai/Juin/Sept/Déc 2024, Mai 2019

[RANG 32] CANCERS BILIAIRES (CHOLANGIOCARCINOME)

Chirurgie • ~0.47 Q/examen (7 Q au total)

🔒 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Cholangiocarcinome – clinique & traitement :

- Ictère CHOLESTATIQUE : permanent, progressif, avec urines foncées + selles décolorées + prurit
- Tumeur de KLATSKIN = cholangiocarcinome du HILE (confluent biliaire supérieur)
- Seul traitement CURATIF = RÉSECTION CHIRURGICALE (exérèse) – souvent diagnostic tardif/non résécable
- ⚠ *FAUX : « selles foncées » – dans la cholestase les selles sont DÉCOLORÉES (mastic)*
- ⚠ *FdR : cholangite sclérosante, lithiase intra-hépatique, kyste du cholédoque, parasitoses biliaires*

📖 Vu dans 4/15 sessions – ex. Juin 2025, Mai 2024, Juin 2023, Mai 2022

[RANG 33] TROUBLES MOTEURS ŒSOPHAGIENS (ACHALASIE)

Médecine • ~0.40 Q/examen (6 Q au total)

🔒 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Note taxonomique :

- ⚠ Topic présent dans les QE mais ABSENT de la liste officielle S6 fournie pour 2026 – traité comme au programme par prudence (aucune annulation confirmée).

Achalasie :

- Absence de relaxation du SIO + apéristaltisme du corps œsophagien (perte des plexus myentériques)
- Clinique : DYSPHAGIE paradoxale (liquides ET solides), régurgitations, douleur thoracique, amaigrissement
- Diagnostic : MANOMÉTRIE œsophagienne (référence) ; TOGD = aspect en « bec d'oiseau » ; FOGD pour éliminer un cancer (pseudo-achalasie)

- ▲ Dysphagie aux liquides dès le début (paradoxale) – différent d'une sténose organique (solides d'abord)
- ▲ Toujours FOGD pour éliminer un cancer du cardia (pseudo-achalasie) avant de conclure

📖 Vu dans 6/15 sessions – ex. Mai/Juin/Sept/Déc 2024, Mai 2022/2023

[RANG 34] PANCRÉATITE CHRONIQUE

Médecine • ~0.33 Q/examen (5 Q au total)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Étiologies & évolution :

- Cause principale : ALC00L ; autres : obstructive, génétique, auto-immune, métabolique (hypercalcémie)
- Évolution : douleur chronique, insuffisance pancréatique EXOCRINE (stéatorrhée) puis ENDOCRINE (diabète), calcifications
- Risque accru d'adénocarcinome du pancréas
- ▲ Pancréatite AUTO-IMMUNE : forme particulière (IgG4), répond aux corticoïdes, mime un cancer

📖 Vu dans 3/15 sessions – ex. Mai 2018/2021, Juin 2021

Pseudo-kyste – complications :

- Pseudo-kyste : infection, rupture, hémorragie (faux anévrisme/wirsungorragie), compression (estomac, VBP), fistule
- ▲ Un pseudo-kyste peut comprimer la voie biliaire → ictère, ou se rompre → ascite pancréatique

[RANG 35] PATHOLOGIES PROCTOLOGIQUES FRÉQUENTES

Médecine • ~0.07 Q/examen (1 Q au total)

🔗 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Note taxonomique :

- Inclut maladie hémorroïdaire & fissure anale (leçons officielles peu/pas taguées séparément).

Repères proctologiques :

- Maladie hémorroïdaire : rectorragie rouge vif terminale, prolapsus, douleur si thrombose ; traitement gradué (hygiéno-diététique → instrumental → chirurgie)
- Fissure anale : douleur intense rythmée par la défécation + contracture sphinctérienne ; siège postérieur médian typique
- ▲ Toute rectorragie après 50 ans → coloscopie (ne pas attribuer d'emblée aux hémorroïdes : risque de méconnaître un cancer)

📖 Vu dans 1/15 sessions

[RANG 36] HÉMOCHROMATOSE

Médecine • ~0.07 Q/examen (1 Q au total)

🔒 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Hémochromatose génétique (HFE) :

- Surcharge en FER (gène HFE, C282Y) → coefficient de saturation de la transferrine ↑↑ + ferritine ↑
- Atteintes : cirrhose (+ risque CHC), diabète bronzé, cardiomyopathie, arthropathie, mélanodermie
- Traitement : SAIGNÉES (phlébotomies)
- ⚠ *Marqueur de dépistage = coefficient de saturation de la transferrine (plus précoce que la ferritine)*

📖 Vu dans 1/15 sessions

[RANG 37] MALADIE DE WILSON

Médecine • ~0.07 Q/examen (1 Q au total)

🔒 Banque de QE (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Maladie de Wilson (surcharge en cuivre) :

- Mutation ATP7B → accumulation de CUIVRE (foie, cerveau, cornée) ; sujet JEUNE
- Bio : céruloplasmine BASSE, cuivre urinaire ÉLEVÉ ; anneau de Kayser-Fleischer (cornée)
- Atteintes : hépatite/cirrhose + signes neuro-psychiatriques ; traitement : chélateurs (D-pénicillamine), zinc
- ⚠ *Évoquer Wilson devant toute hépatopathie du sujet jeune + signes neurologiques*

📖 Vu dans 1/15 sessions

[RANG 38] QUESTIONS TRANSVERSALES / INCLASSIFIABLES

Transversal • ~1.93 Q/examen (29 Q – non rattachées à une leçon unique)

Indications & limites de la cœlioscopie (récurrent) :

- Indications larges : cholécystite lithiasique/alithiasique, appendicite, hernie, exploration
- CONTRE-INDICATION majeure : suspicion de dégénérescence MALIGNNE (ex. vésicule) → risque de dissémination
- ⚠ *« Lithiase vésiculaire avec dégénérescence maligne » = la seule NON indiquée en cœlio (piège classique)*

Démarche devant une urgence abdominale :

- Épigastralgie aiguë → évoquer PA, ulcère/perforation, gastrite, abcès hépatique (penser large)
- Masse FID indolore chronique → plastron appendiculaire + tumeur cœcale
- ⚠ *Ces questions mélangent plusieurs leçons : réviser les diagnostics différentiels par symptôme-clé*

📖 Vu dans 2/15 sessions – ex. Juin 2025, autres

PARTIE 4 – TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER – À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé – NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK – BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~0% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

(Aucun topic hors programme – tous les topics correspondent aux leçons officielles cette année.)

AIDE-MÉMOIRE FINAL – HIGH-YIELD CONCOURS GASTRO-ENTÉROLOGIE & CHIRURGIE VISCÉRALE (PATHOLOGIE DIGESTIVE, S6)

** CLASSIFICATIONS & SCORES À RETENIR **

Child-Pugh (A/B/C)	Cirrhose – 5 items : Bilirubine, Albumine, TP, Ascite, Encéphalopathie
TNM rectum + IRM	T3 → radio-chimiothérapie néo-adjuvante puis exérèse (TME)
Balthazar / CTSI	Gravité TDM de la pancréatite aiguë
Zargar	Stades endoscopiques des brûlures caustiques
Rome IV	Critères du syndrome de l'intestin irritable

** MARQUEURS & EXAMENS-CLÉS **

Marqueur / Critère	Indication
Lipasémie > 3N	Confirmation de la pancréatite aiguë (≠ troponine/ECBU)
TP / Facteur V bas	Gravité de l'hépatite aiguë (≠ intensité de la cytolyse)
IgA anti-transglutaminase	Dépistage de la maladie cœliaque (+ biopsies duodénales)
Coeff. saturation transferrine ↑	Hémochromatose (plus précoce que la ferritine)
Céruloplasmine basse + cuivre urinaire ↑	Maladie de Wilson
Test respiratoire / Ag selles	Contrôle d'éradication de H. pylori (PAS la sérologie)
AFP + nodule sur cirrhose	Carcinome hépatocellulaire
Ascite exsudat lymphocytaire	Tuberculose péritonéale (≠ transsudat de la cirrhose)

** PIÈGES CLASSIQUES DU CONCOURS **

- ▲ *Plastron appendiculaire = ANTIBIO + appendicectomie DIFFÉRÉE – jamais de chirurgie en urgence.*
- ▲ *OIA aiguë : confirmation = SCANNER (jamais TOGD/coloscopie/FOGD).*
- ▲ *Cancer du CÔLON : hérédité EST un facteur ; traitement = chirurgie (la radiothérapie c'est le RECTUM).*
- ▲ *Cancer du rectum T3 : RCT néo-adjuvante AVANT la chirurgie, pas de chirurgie première.*

- ▲ KH du dôme hépatique : FRÉQUENT au Maroc, segments 7-8 ; PAS la cœlioscopie de choix.
- ▲ Pancréatite aiguë au Maroc : 1^{re} cause = LITHIASÉ biliaire (pas l'alcool).
- ▲ Child-Pugh : 5 items ABATE – n'inclut NI transaminases NI créatinine.
- ▲ Ingestion de caustique : vomissements/lavage/SNG/neutrisant = TOUS proscrits.
- ▲ Cholestase : selles DÉCOLORÉES (mastic), pas foncées.
- ▲ VHA/VHE : jamais de chronicité ; cancérisation = ulcère GASTRIQUE (jamais duodénal).
- ▲ Ag HBs-/anti-HBs+/anti-HBc- = VACCINÉ (l'anti-HBc absent fait la différence).
- ▲ Cœlioscopie : contre-indiquée si dégénérescence maligne suspectée.

**** SÉQUENCES & CHAÎNES PHYSIOPATHOLOGIQUES ****

- RGO chronique → endobrachyœsophage (Barrett) → dysplasie → ADÉNOCARCINOME du bas œsophage.
- Gastrite chronique à H. pylori → atrophie → métaplasie intestinale → dysplasie → ADÉNOCARCINOME gastrique.
- Adénome (polype) colique → dysplasie → ADÉNOCARCINOME colorectal (séquence adénome-cancer).
- Cirrhose → carcinome hépatocellulaire (dépistage écho/6 mois).
- Lithiasé biliaire → migration → pancréatite aiguë biliaire (1^{re} cause au Maroc).
- Embolie (ACFA) / thrombose AMS → ischémie mésentérique → nécrose → péritonite → choc.

Généré par Claude.ai (claude-opus-4-8) – Version 1

Cross-match 748 QEs officielles × Cours AIO digestif + corrections officielles e-qe.online

FMPM – Concours 2026 • généré par Claude.ai

Améliorations Version 1 :

- ✓ PARTIE 3 strictement par rang de fréquence (1 → N).
- ✓ Déduplication : 1 entrée par concept, FAUX explicites avec ▲.
- ✓ Citations réelles (sessions présentes dans la banque) – aucune fabrication.
- ✓ Corrections fondées sur les clés officielles ; clés 'discutables' signalées.
- ✓ PARTIE 4 vide : aucune liste officielle de cours annulés 2026 fournie (disclaimer obligatoire).
- ✓ Notes taxonomiques : fusions de tags (Hépatites = 3 leçons ; malabsorption + cœliaque) explicitées.
- ✓ Achalasie : présente en QE mais absente de la liste S6 fournie – signalée, traitée comme au programme.